

Kryteria CSBD wg ICD-11

Od 2022 r. WHO oficjalnie uznaje kompulsywne zaburzenie zachowań seksualnych (CSBD) jako diagnozę. Pięć precyzyjnych kryteriów decyduje, czy spełniasz definicję.

CZAS: 25 min **Wiedza diagnostyczna** **ŹRÓDŁO:** WHO ICD-11 (2022); Kraus i wsp. (2018, World Psychiatry)

JAK UŻYWAĆ

Karta przedstawia oficjalne **kryteria diagnostyczne CSBD** (ang. *Compulsive Sexual Behavior Disorder*, kompulsywne zaburzenie zachowań seksualnych) wg ICD-11 (kod 6C72). To *pierwsza międzynarodowa diagnoza* obejmująca PPU. Karta zawiera: 1) **pięć kryteriów** (A–E), 2) co konkretnie liczy się a co nie, 3) trzy *wykluczenia* (kiedy NIE diagnozujemy CSBD), 4) jak to wpływa na leczenie i refundację NFZ.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Przed 2022 r. „uzależnienie od seksu” / „uzależnienie od porno” **nie miało oficjalnej diagnozy**. To powodowało: 1) *nieprecyzję* — każdy klinicysta diagnozował inaczej, 2) *nadrozpoznanie* — osoby z niespójnością moralną dostawały etykietę uzależnienia, 3) *brak refundacji* NFZ. Kraus i wsp. (2018, *World Psychiatry*) opublikowali propozycję, którą WHO przyjęło w ICD-11 (obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.). Praktyczne znaczenie: **jasne kryteria** pozwalają odróżnić CSBD od „intensywnego seksu”, „nieortodoksyjnych preferencji” i „konfliktu moralnego”. W Polsce CSBD jest **kodowane jako 6C72** i kwalifikuje do leczenia w ramach NFZ (poradnie zdrowia psychicznego, poradnie seksuologiczne).

01 Pięć kryteriów CSBD (ICD-11, kod 6C72)

A · UTRWALONY WZORZEC

„Utrwalony wzorzec trudności w kontrolowaniu intensywnych, powtarzających się impulsów seksualnych, prowadzący do powtarzającego się zachowania seksualnego”. **Czas trwania:** co najmniej 6 miesięcy. Sporadyczne nadmierne używanie pornografii (np. po stracie) nie spełnia.

B · CENTRALNOŚĆ W ŻYCIU

„Powtarzające się zachowania seksualne stają się *centralnym punktem* życia osoby, w której zachowanie to pochłania znaczącą część czasu i energii, z zaniedbaniem zdrowia, opieki nad sobą, innych zainteresowań, aktywności i odpowiedzialności”. **Operacyjnie:** >2 h dziennie lub znacząca redukcja innych aktywności.

C · LICZNE NIESKUTECZNE PRÓBY

„Liczne nieudane próby istotnego zredukowania powtarzających się zachowań seksualnych”. **Operacyjnie:** 3+ świadome próby ograniczenia / abstynencji zakończone niepowodzeniem.

D · KONTYNUACJA MIMO SZKÓD

„Kontynuacja powtarzających się zachowań seksualnych mimo niekorzystnych konsekwencji lub gdy zachowanie przestało dawać satysfakcję”. **Operacyjnie:** konkretna szkoda (kłótnie, konsekwencje w pracy, finansowe, zdrowotne) — a wzorzec trwa.

E · CIERPIENIE / DYSFUNKCJA

„Wzorzec powoduje wyraźny dystres lub znaczące upośledzenie w sferze osobistej, rodzinnej, społecznej, edukacyjnej, zawodowej lub innych ważnych sferach funkcjonowania”. **Operacyjnie:** co najmniej jeden obszar życia mierzalnie cierpi.

02 ✕ Wykluczenia — kiedy NIE diagnozujemy CSBD

1 · WYŁĄCZNI KONFLIKT MORALNY

„Dystres związany wyłącznie z osądami moralnymi i dezaprobatą impulsów seksualnych, popędów lub zachowań NIE jest wystarczający, by spełnić to kryterium” — cytāt z ICD-11. Niespójność moralna ≠ CSBD.

2 · LEPIEJ WYJAŚNIONE PRZEZ INNE ZABURZENIE

Epizod maniakałny (CHAD), efekt substancji, parafilia (zaburzenia preferencji), psychoza — jeśli zachowanie wynika z innego zaburzenia, diagnozujemy to zaburzenie, nie CSBD.

3 · WYSOKA AKTYWNOŚĆ BEZ CIERPIENIA

Intensywne używanie pornografii bez cierpienia i bez upośledzenia funkcjonowania *nie jest* CSBD. ICD-11 nie patologizuje wysokiej aktywności seksualnej samej w sobie.

03 ✎ Twój samo-screening — 5 kryteriów

Postaw krzyżyk obok kryteriów, które rozpoznajesz u siebie *w ostatnich 6 miesiącach*. Spełnienie wszystkich 5 sugeruje CSBD — wymaga to potwierdzenia przez klinicystę.

- ☐ **A.** Mam trwałe trudności z kontrolowaniem impulsów seksualnych przez co najmniej 6 mies.
- ☐ **B.** Zachowania seksualne pochłaniają znaczną część mojego czasu i energii (zaniedbuję inne sfery).
- ☐ **C.** Wielokrotnie próbowałem/-am ograniczyć — bez powodzenia.
- ☐ **D.** Kontynuuję mimo widocznych negatywnych konsekwencji.
- ☐ **E.** Wzorzec powoduje wyraźny stres lub upośledza co najmniej jedną sferę życia (poza moralnym osądem).

04 ✎ Mój wynik — co dalej

ILE KRYTERIÓW ROZPOZNAJĘ U SIEBIE

— A, B, C, D, E

CZY MOJE CIERPIENIE WYNIKA TYLKO Z MORALNEGO OSĄDU

— jeśli tak: nie spełniam CSBD, omów to z terapeutą

Klucz: ICD-11 (2022) wprowadziło CSBD jako *kompromis* między pełnym uznaniem „uzależnienia seksualnego” (jak chce wielu klinicystów) a brakiem diagnozy (jak chcą krytycy patologizacji). Stąd CSBD jest sklasyfikowane w „**zaburzeniach kontroli impulsów**”, NIE w „uzależnieniach”. Praktyczna konsekwencja: terapia, choć korzysta z technik uzależnieniowych (CBT, profilaktyka nawrotów), **nie wymaga abstynencji seksualnej** jako celu. Cel: *odzyskanie kontroli*. Dla części pacjentów = abstynencja od pornografii; dla innych = redukcja używania; dla innych = integracja używania z wartościami.